

INDICADO POR: Rodolfo Bonato + Facebook

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS E5424A06095

PAULO RODOLFO GUIMARÃES

IDADE: 56 PESO: 72 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: gerente projeto

SINTOMAS: Dor no pescoço

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Lamoxigina / Ibuprofeno

MÉDICO: Dr. Paulo Roberto Figueiredo (Otorrinolaringologista)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 1x semana (musculação)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 21-22h

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: (X) S (X) N PET NO QUARTO: (X) S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 19,3cm SPO2: 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: ansiedade / colesterol

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

08/05/25 Avaliação Lotação Auto 5-10cmH₂O
umac deam wear (3)
Natacha19/05 P= 8,3cmH₂O
25 IAH= 9,4 e l/v Budeixa de acordar
e não conseguir voltar
M. de uso: 3h40' a usar, melhorou
p/ dormir. — sua09/06 não chegou dados do CPAP
IAH 4 todo o CPAP que23/07 P= 8cmH₂O
25 IAH= 5,5 e l/v
M. de uso= 6h13' sua
fuga= 5,8 lpru.

Nome: PAULO RODOLFO GUIMARÃES
Data de Nascimento: 24-2-1969
IMC: 25,34
Sexo: Masculino
Data do exame: 19-04-2024

Peso: 69 kg
Altura: 1,65 m
Médico: DR. PAULO ROBERTO
FIGUEREDO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-04-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 566,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 146,5 e 137,0 minutos. O tempo total de sono foi de 379,0 min, eficiência de 67,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,4%; estágio N2: 60,9%; estágio N3: 15,6%; sono REM: 20,1%. O índice de despertares foi de 7,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 19,3/hora, sendo 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 80 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 83%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 106 bpm e NREM de 55 - 99 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 19,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=83%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.
Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157